AULA DE SALUD COMUNITARIA · PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2027

Del conocimiento del territorio a las prioridades

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Ciclo de planificación local, estatuto de la evidencia, activos, participación y priorización deliberativa.

Qué aprenderemos

- Reconocer las seis etapas de la planificación local y los productos de cada una.
- Distinguir qué marco aporta qué: RELAS (procedimiento), EPVSA (contenidos), ESCA (mandato del sistema sanitario).
- Clasificar la información del diagnóstico según su estatuto: hecho, inferencia, hipótesis o decisión.
- Aplicar criterios de priorización y documentar la deliberación y lo que queda fuera.

Agenda

09:00–09:30
Presentación, cuestionario inicial y experiencias previas con planes locales

09:30–10:20
El ciclo de planificación local y la regla de no mezclar etapas. Marcos RELAS, EPVSA y ESCA

10:20–11:15
Necesidades, activos y participación como evidencia. Ejercicio: estatuto de los enunciados

11:15–11:45
Descanso

11:45–13:00
Taller de priorización con el caso Sierranueva

13:00–13:45
Plenario: comparar priorizaciones y explicar las diferencias

13:45–14:00
Cierre y presentación del trabajo T1

1. El ciclo de planificación local

Diagnóstico
Producto: Información organizada y con procedencia · Lo que aún no debe aparecer: Interpretaciones, prioridades u objetivos

Perfil de salud local
Producto: Lectura interpretativa y trazable de la evidencia · Lo que aún no debe aparecer: Qué se hará, quién y con qué recursos

Del conocimiento del territorio a las prioridades

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Planificación
Producto: Plan de acción: prioridades, objetivos, actuaciones, indicadores con tiempo cero y meta · Lo que aún no debe aparecer: Resultados de la ejecución

Decisión política
Producto: Plan Local de Salud aprobado por el órgano municipal · Lo que aún no debe aparecer: Actuaciones ejecutadas como si ya fueran compromisos del plan

Ejecución
Producto: Actuaciones realizadas y datos de seguimiento · Lo que aún no debe aparecer: Juicios sobre si el plan funciona

Evaluación
Producto: Informe de evaluación, que abre el siguiente diagnóstico · Lo que aún no debe aparecer: Conclusiones de cambio sin comparación con el tiempo cero

Por qué no mezclar etapas

- Diagnóstico con sesgo de planificación: se busca evidencia de lo que ya se ha decidido priorizar; el diagnóstico confirma en lugar de descubrir.
- Perfil que ya propone actuaciones: el equipo técnico ocupa decisiones que corresponden al Grupo Motor.
- Plan que es diagnóstico: la mayor parte del documento describe la situación y el lector no encuentra qué se va a hacer.
- Evaluación sin tiempo cero: no se registró el valor de partida y no se puede saber cuánto cambió.

2. Qué aporta cada marco

RELAS
Qué es: Metodología de proceso municipal: Grupo Motor, participación, ciclo del plan · Qué no aporta: Contenidos, prioridades o indicadores locales

EPVSA 2024-2030
Qué es: Estrategia de contenidos: 4 líneas y 10 objetivos estratégicos, con indicadores de contexto e impacto · Qué no aporta: Prioridades de cada municipio. Casi cualquier prioridad encaja en alguna línea: la alineación no valida una prioridad

ESCA 2026-2030
Qué es: Estrategia del sistema sanitario público para atención primaria. Tres niveles de orientación comunitaria: individual y familiar, grupal y colectivo · Qué no aporta: Las actuaciones de iniciativa municipal ni los recursos del Ayuntamiento

Una distinción que evita errores

Lo que la ESCA encarga al centro de salud es un compromiso del sistema sanitario, no del municipio. El plan local debe identificar qué actuaciones son propias del municipio y cuáles corresponden al distrito sanitario. Así se evitan dos errores simétricos: creer que el plan local sobra porque la ESCA ya lo cubre, o diseñarlo ignorando lo que el sistema sanitario ya debe

Del conocimiento del territorio a las prioridades

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

hacer.

3. Tipos de necesidad (Bradshaw)

Normativa
Quién la define: Criterio técnico o umbral · Ejemplo en Sierranueva: Consumo de alcohol en menores: cualquier consumo es un problema según el criterio sanitario

Comparativa
Quién la define: Comparación con territorios similares · Ejemplo en Sierranueva: 24,1 % de población mayor frente a 18,9 % provincial

Sentida
Quién la define: Percepción de la población · Ejemplo en Sierranueva: 96 selecciones sobre soledad no deseada

Expresada
Quién la define: Demanda efectiva de servicios o recursos · Ejemplo en Sierranueva: Lista de espera de los huertos urbanos

Activos y participación

Los activos se leen con el mismo rango que los déficits: un diagnóstico no es un inventario de carencias. La participación ciudadana aporta conocimiento que la epidemiología no recoge, pero su valor depende de quién ha podido participar. Una consulta que solo recoge la voz de los grupos más activos no puede presentarse como la opinión del municipio.

Ejercicio: estatuto de los enunciados (20 minutos)

En grupo, clasificar cada enunciado como hecho, inferencia, hipótesis o decisión, y señalar qué haría falta para cambiar su estatuto.

El 24,1 % de la población tiene 65 años o más (padrón 2025).
Hecho

Sierranueva está más envejecida que su provincia.
Inferencia apoyada en una comparación explícita

La soledad no deseada es el principal problema percibido por la población.
Inferencia no sostenida: la consulta no es representativa

La soledad no deseada explica el malestar emocional de las personas mayores.
Hipótesis causal sin evidencia local

598 personas mayores viven solas, por tanto 598 sufren soledad.
Error: confunde convivencia con soledad no deseada

Del conocimiento del territorio a las prioridades

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Los huertos urbanos podrían acoger actividades intergeneracionales.
Hipótesis de actuación (pertenece a la planificación)

El Grupo Motor sitúa la soledad no deseada como primera prioridad.
Decisión

4. Taller de priorización

Primer paso: listar las necesidades candidatas con su evidencia. Segundo: puntuar con criterios explícitos. Tercero: deliberar, porque la puntuación orienta pero no decide. Cuarto: dejar constancia de lo que no se prioriza y por qué.

Criterios

Magnitud
¿A cuántas personas afecta?

Gravedad
¿Qué daño produce en la salud?

Modificabilidad
¿Existen intervenciones eficaces a nuestro alcance?

Inequidad
¿Afecta más a grupos en peor situación?

Viabilidad local
¿Tiene el municipio capacidad y aliados para actuar?

Demanda ciudadana
¿La comunidad la ha expresado? ¿Quién la ha expresado?

Método Hanlon (versión de trabajo)

- A · Magnitud (0 a 10). B · Gravedad (0 a 10). C · Eficacia de la intervención (0 a 10).
- Puntuación básica = (A + 2B) × C / 3.
- Filtro PEARL (pertinencia, viabilidad económica, aceptabilidad, recursos, legalidad): si alguno es «no», la necesidad no se aborda en este ciclo y se documenta el motivo.
- Advertencia: el método ordena un juicio, no lo sustituye. Una diferencia de pocos puntos entre dos necesidades no justifica por sí sola la decisión.

Del conocimiento del territorio a las prioridades

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Plenario

- ¿Coinciden las prioridades de los grupos? ¿Qué criterio explica las diferencias?
- ¿Cómo influyó la consulta ciudadana? ¿Qué voces faltaban?
- ¿Qué necesidad queda fuera y cómo se justifica ante la comunidad?

Criterio de cierre

Cada grupo debe poder explicar qué ha priorizado, con qué evidencia, qué peso tuvo la voz ciudadana y qué ha dejado fuera.

El caso Sierranueva es ficticio: sus datos son inventados para la docencia. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.